Evaluación e intervención desde el modelo cognitivo-conductual y sistémico

5

ESQUEMA/CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

1. INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN EL MARCO DE LA COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA

2. MODELO COGNITIVO-CONDUCTUAL

- 2.1. Fundamentos teóricos
- 2.2. La modificación de conducta conductual-cognitiva
- 2.3. Prevención en el aula
- 2.4. Proceso de intervención
  - 2.4.1. Fase de evaluación inicial
  - 2.4.2. Fase de intervención
  - 2.4.3. Fase de seguimiento
- 2.5. Técnicas de intervención

3. MODELO SISTÉMICO O ECOLÓGICO-CONTEXTUAL

- 3.1. El proceso de intervención en el modelo sistémico
  - 3.1.1. Primera fase: evaluación-diagnóstico
  - 3.1.2. Segunda fase: intervención
  - 3.1.3. Tercera fase: seguimiento y evaluación final
- 3.2. Conclusiones

REFERENCIAS

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describen en detalle los modelos sistémico o ecológico-contextual y el cognitivo-conductual, ambos marcos son los más utilizados en el ámbito de la educación, el trabajo social, y la orientación en general. Y el motivo está en la investigación continuada que se viene desarrollando entorno a estos modelos.

A continuación, se presentarán, de forma resumida ambos modelos, haciendo hincapié en las fuentes teóricas en las que se basan, no obstante, el detalle de estos modelos se puede consultar igualmente en el capítulo dos de esta obra, junto con otros modelos, que, en conjunto, dan soporte teórico a la orientación educativa. De igual forma, y en la segunda parte de este capítulo, se detallará el proceso de intervención, cuyas fases se desarrollan en la segunda parte de este capítulo, y constituyen el protocolo de intervención que se seguirá en la resolución de los casos prácticos de orientación familiar y acción tutorial, y que se articulan en torno a: el diagnóstico, el plan de orientación, la evaluación de los resultados y del proceso.

1. INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN EL MARCO DE LA COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN FAMILIA-ESCUELA

Las familias son diversas, y partiendo de esta constatación las intervenciones se diseñan en el marco de sus diferentes contextos y teniendo en cuenta el momento evolutivo en el que se encuentren estas. En este sentido, Espe-Sherwindt (2008) identifica un continuo cuyos extremos corresponden a las intervenciones basadas en el profesional y en las que se centran en las familias respectivamente. De esta forma, define cuatro enfoques de intervención:

- Modelo centrado en el profesional. En este tipo de intervención se encontraría el modelo de asesoramiento (*counseling*), con protagonismo por parte del profesional y la familia asume un role más pasivo.

- Modelo de la *familia como aliada*. El profesional sigue apareciendo como experto, pero en este caso, se le reconoce a la familia la capacidad para llevar a cabo en el hogar las pautas prescritas por este.

Tabla 5.1
Modelos, roles y responsabilidades de profesionales y familias en la toma de decisiones y en la intervención

Modelo	Rol del profesional	Rol de la familia	Decisión sobre objetivos	Intervención
Profesional experto	Experto Identifica necesidades y plantea soluciones Responsable exclusivo del programa	Pasivo: llevan al/a la hijo/a para la intervención	Profesional	Intervención ambulatoria a cargo del profesional
Familia aliada	Experto Identifica necesidades y plantea soluciones Enseña y forma a las familias en el programa	Activo: aplicar en casa lo que prescriba el profesional	Profesional	Intervención ambulatoria a cargo del profesional, y en casa a cargo de la familia
Enfocado en la familia	Experto Identifica necesidades y plantea soluciones Orienta a las familias	Algo activo Aplica en casa lo que prescriba el profesional	Profesional plantea opciones Familia decide entre ellas, especialmente en actuaciones de la familia en casa	Intervención ambulatoria a cargo del profesional Orientaciones para la familia en casa, poco seguimiento
Centrado en la familia	Tutor y orientador de la familia Generador de entornos competentes Corresponsable del programa de intervención	Activo Experta en las necesidades del niño y en el entorno natural de la misma Corresponsable del programa de intervención	Consensuado y acordado entre familias y profesional Compromiso compartido	Intervención a través de la familia en el entorno natural Aprovechamiento de las rutinas para promover oportunidades de aprendizaje mediado por el contexto

Fuente: Adaptado de García-Sánchez, Escorcia, Sánchez-López, Horcajada y Hernández-Pérez, 2014.

- Modelo enfocado en la familia. Se le da algo más de poder a las familias.
- Modelo centrado en la familia. Se contempla a la familia como una unidad, trabajando en sus fortalezas y capacidades.

2. MODELO COGNITIVO-CONDUCTUAL

El modelo conductual-cognitivo se ha difundido ampliamente entre los profesionales de la orientación educativa y familiar. A pesar de las críticas, y de la oposición en determinados casos, sigue siendo un modelo vigente, y su campo de actuación ha aumentado y se ha diversificado. Desde sus inicios, el objetivo principal fue solucionar problemas de las personas, los grupos y las instituciones, aunque sin olvidar la prevención de los mismos. Del ámbito clínico derivó al de la educación, al empresarial y al de las comunicaciones; y actualmente se trabaja e investiga prácticamente en cualquier área, grupo e institución donde la conducta humana facilite o interfiera la comunicación, las relaciones interpersonales o el logro de los objetivos.

2.1. Fundamentos teóricos

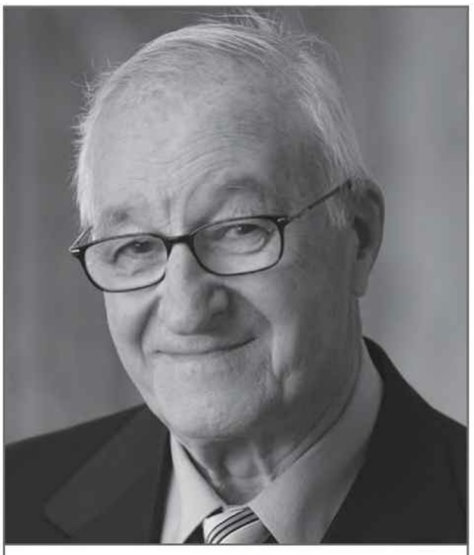
El modelo conductual-cognitivo se fundamenta en las aportaciones del conductismo y de la psicología cognitiva. La fuente teórica y metodológica del conductismo cuya idea base es que la conducta humana es aprendida y puede ser modificada con intervenciones adecuadas De la psicología cognitiva toma como base el concepto de desarrollo humano como proceso en continuo cambio. Desde este modelo, la función principal del orientador es la de mediador entre la persona que aprende y los estímulos externos; la insuficiencia o inadecuada mediación dificulta el aprendizaje y facilita la aparición de problemas..

2.2. La Modificación de Conducta Conductual-Cognitiva

La Modificación de Conducta se conceptualiza como ciencia aplicada con formulaciones teóricas propias, métodos y diseños de investigación, técnicas y procedimientos de intervención, tanto para la prevención de problemas o dificultades como para la solución de estos.

La base teórica es el conductismo metodológico o estudio científico en el análisis de la conducta y de su modificación, iniciada por J.B. Watson. A partir de la década de los años 50 del pasado siglo los trabajos de Skinner despertaron mayor interés y fomentaron trabajos de laboratorio y publicaciones científicas. La teoría del aprendizaje social de Bandura (1971) ejerció una fuerte influencia y el enfoque en la intervención dejó de ser exclusivamente remedial para adoptar el preventivo, ampliando el cam-

po de actuación al ámbito educativo; posteriormente se incorporaron los presupuestos de la psicología cognitiva lo que permitió desarrollar nuevas estrategias aplicables tanto a la prevención de problemas, como a la solución de estos.



Albert Bandura, psicólogo canadiense-estadounidense. Fue profesor de la U. de Stanford, reconocido por su teoría del aprendizaje social y su evolución al sociocognitivismo, así como por su postulado la categoría de autoeficacia.

El modelo de la Modificación de Conducta Cognitivo-Conductual explica el comportamiento humano como el resultado de la interacción dinámica entre el individuo y el ambiente físico y social; dicha interacción está determinada por muchos y diversos factores, algunos de los cuales son:

- Biológicos: genéticos, prenatales, perinatales y estado nutricional.
- Historia personal: incluye las experiencias vividas por la persona en cada uno de los grupos de pertenencia o de referencia.
- Tipo de aprendizaje.
- Calidad y cantidad de los estímulos recibidos.
- La forma en que se aprendió su comportamiento y las consecuencias derivadas de las conductas emitidas.
- Las características de los contextos familiares y comunitarios de la persona.

Los factores de carácter biológico relacionados con la genética y el desarrollo, los eventos prenatales y perinatales son los responsables de que un organismo se desarrolle dentro de parámetros adecuados a su edad o puedan determinar la disfuncionalidad o desadaptación de diversas conductas.

La historia personal, el aprendizaje a través de los acontecimientos vividos, la calidad y cantidad de los estímulos recibidos, la forma en que se adquirieron los comportamientos y las consecuencias derivadas son pautas para la comprensión de la probabilidad de que vuelvan a repetirse o no. Por último, pero no menos importante son los entornos familiares y comunitarios, el medio físico, el ambiente socioeconómico y cultural en el que la persona esté viviendo forman la red de interacciones en la que la persona responde a las expectativas propias y de los grupos en los que se desarrolla.

2.3. Prevención en el aula

Estilos docentes, condicionantes del aprendizaje y la gestión del aula

Hervás Avilés (2005), señala el interés de apuntar hacia la conveniencia de que se dé una coincidencia entre estilos docentes de enseñanza y los estilos de aprendizaje

del alumnado, lo que no quiere decir que los contenidos de los aprendizajes se deban presentar siempre de la misma forma. Por esta razón, si el profesorado identifica sus estilos de enseñanza, a partir de ese conocimiento, se podrán diseñan y elaborar las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Desde esta adecuación de estilos se facilita la respuesta a la diversidad del alumnado, promoviendo el desarrollo y los aprendizajes, además, tendrá impacto sobre el desarrollo cognitivo, social, emocional y actitudinal del alumnado.

Los factores citados actúan de forma interrelacionada en la conducta humana; el tipo de intervención los tiene en cuenta y ha de fundamentarse en los supuestos que se derivan de dicha interrelación; en el ámbito profesional de la orientación y la terapia se citan los siguientes:

a) El objetivo prioritario del Análisis Funcional de la Conducta es identificar los factores o causas de las conductas, con el fin diseñar y aplicar programas adecuados para modificarlas, mantenerlas en el tiempo y generalizarlas.

b) Con el Análisis Funcional no se persigue etiquetar ni clasificar a las personas; tampoco comparar su comportamiento con el de los demás, sino con ellas mismas.

c) Los comportamientos, tanto los que son objeto del análisis funcional como de la intervención propiamente dicha, han de ser formulados de forma observable, mensurable y verificable empíricamente.

2.4. Proceso de intervención

En este apartado se presenta la forma más habitual de intervención desde el modelo cognitivo-conductual. En este apartado se presenta el protocolo a través del cual se lleva a cabo dicha intervención con la finalidad de solucionar los problemas y dificultades planteados, bien desde el contexto familiar, desde el escolar o en ambos. También se desarrollan otros programas enfocados a la prevención de dificultades, conflictos o problemas.

El proceso de intervención se lleva a cabo a través de tres fases: 1) evaluación inicial, 2) intervención, 3) seguimiento y evaluación final; cada una de estas fases se lleva a la práctica siguiendo una secuencia o protocolo que ha de ser coherente con todo el proceso; en la tabla 5.2 se presentan las tres fases con sus correspondientes pasos.

Tabla 5.2
Fases del proceso de intervención

Modelo	Modelo
1. Evaluación	1. Identificación y descripción del problema. 2. Definición operativa de la conducta. 3. Formulación de objetivos finales. 4. Análisis funcional de la conducta y del ambiente. 5. Formulación de la hipótesis funcional.
2. Intervención	1. Formulación de la hipótesis de intervención. 2. Elaboración del programa de intervención. 3. Aplicación del programa. 4. Evaluación continua de la intervención. 5. Desvanecimiento del programa.
3. seguimiento	1. Programación del seguimiento. 2. Mantenimiento y generalización del cambio. 3. Evaluación del seguimiento.

Fuente: Adaptado de García Mediavilla, L. y Martínez González, M. de C. (2003). Basado en Cidad (2001).

2.4.1. Fase de evaluación inicial

Esta fase se desarrolla, generalmente, en cinco pasos sucesivos; en el primero se identifica y describe el problema central, en el segundo se define la conducta de forma operativa, en el tercero se formulan los objetivos finales, en el cuarto se realiza el análisis funcional de la conducta del sujeto, en el quinto se formula la Hipótesis funcional. En la tabla 5.3 especificamos cada uno de estos pasos, las tareas que implican y ejemplos de cómo se concretan las tareas.

La fase primera se inicia con la identificación y descripción del problema y continúa con la definición operativa de la conducta; en la práctica, ambos pasos son tan similares que pueden identificarse; la diferencia esencial consiste en que mientras el problema se formula de forma genérica, un ejemplo individual, «molesta a los compañeros de clase», «siente celos de la hermana recién nacida», y en el caso de un grupo: «no permiten que los alumnos nuevos participen en los juegos», la definición operativa de la conducta es más concreta, y se expresa en términos operativos, es decir, se trata de conductas que se pueden observar y medir con facilidad, un ejemplo individual, «rompe sus cosas, no respeta el turno de palabra, se levanta continuamente de su asiento», o «molesta a los compañeros de clase», y en el caso de un grupo: «se insultan e inician peleas a la salida del colegio». La metodología de la modificación de conducta exige que los objetivos se formulen con claridad, precisión, brevedad y en forma de conductas observables y medibles.

Tabla 5.3
Proceso de intervención. Fase de evaluación inicial

Pasos sucesivos	Tareas	Tareas
1. Identificación y descripción del problema.	Describir el problema en términos observables y medibles (respecto a una persona o grupo).	■ Molesta a los hermanos. ■ Se distrae en clase. ■ Impiden la participación de los nuevos compañeros.
2. Definición operativa de la conducta.	Expresar la conducta en términos operativos concretos (respecto a una persona o grupo).	■ Rompe los juguetes de sus hermanos. ■ Tira papeles en clase. ■ Se burlan de ella cuando se tapa los oídos por el ruido.
3. Formulación de objetivos finales.	Ponderar criterios. «Qué metas queremos alcanzar.»	■ Dejar de molestar a los hermanos. Atender en clase. ■ Eliminar las burlas hacia la compañera.
4. Análisis funcional:		
■ Cuantificación de la conducta y obtención de la línea base.	■ Observar, registrar, graficar las conductas que se quieren modificar (respecto a una persona o grupo).	■ Recuento de frecuencias. Trazado de gráficas de frecuencias y de la línea base.
■ Identificación de características relevantes. ■ Análisis del ambiente que rodea al sujeto o grupo.	■ Analizar los prerrequisitos.	■ Dividir la conducta final que se quiere alcanzar en secuencias sucesivas simples. Comprobar cuáles de ellas están adquiridas.
	■ Detectar, observar y registrar el estado biológico de la persona o grupo.	■ Elaborar las historias personales (salud, enfermedad, déficits, etc.).
	■ Detectar, observar y registrar el estado general de la persona o grupo y el entorno en el que vive/n.	■ Elaborar la/s historia/s de antecedentes y consecuentes de la conducta: premios y castigos, modelos familiares y escolares, adaptación en la familia y en la escuela, historiales académicos, barrio, aficiones, gustos, intereses, etc.

Pasos sucesivos	Tareas	Tareas
5. Formulación de la hipótesis funcional (HF)	Redactar la HF.	■ *...tiene un problema de inseguridad porque no se siente querido, por eso trata de llamar la atención de los demás.* ■ Se observa escasa cohesión en el grupo de aula.

Fuente: Adaptado de García Mediavilla, L. y Martínez González, M. de C. (2003). Basado en Cidad (2001).

El análisis funcional de la conducta, que en el proceso de intervención se concreta en la Hipótesis funcional, tiene por objeto identificar los factores responsables de los comportamientos disruptivos y la relación que se establece entre ellos. Para ello es preciso cuantificar la conducta que se quiere modificar y hallar la línea base o medida inicial de la conducta; está acción se realiza antes de comenzar la intervención y sirve como referencia para comparar los cambios en la conducta derivados de la aplicación del programa. Implica determinadas destrezas y la utilización de recursos o instrumentos que, en el planteamiento clásico de Cidad (2001) se resume en los siguientes:

- Observación con las siguientes condiciones: la observación se debe llevar a cabo sobre la persona o grupo cuando están presentes, el observador debe prestar su atención de forma voluntaria, y seleccionar los elementos comportamentales relevantes; además tiene que conocer el objetivo de la observación; en cuanto a la descripción de lo observado será clara, controlando los errores que pudieran sesgarla.
- Registro de la observación. Incluye la medida, la duración y distribución de las sesiones de observación, los lugares en los que se va a observar, los instrumentos que se van a emplear y la implicación y conducta del observador. Se pueden utilizar distintas modalidades de registro: recuento de frecuencias, registro de duración, muestreo de tiempo, registro anecdótico, producto permanente, registro de categorías.
- Graficación de los registros. La representación gráfica de los datos facilita la comprensión de lo que sucede a lo largo de todo el proceso: evaluación, intervención, seguimiento.

El análisis funcional de la conducta implica también identificar las características relevantes de la persona o grupo observados: estado general, antecedentes y consecuentes de las conductas y si la o las conductas que se quieren modificar están presentes, aunque sea mínimamente, en el repertorio comportamental. Los prerrequisitos son los comportamientos imprescindibles o suficientes que la persona o personas tienen que poseer para poder alcanzar el objetivo final.

La Hipótesis funcional es la valoración que la orientadora o el orientador hace respecto al problema que se quiere solucionar; en dicha Hipótesis funcional se especifican: la naturaleza de las variables que constituyen el problema, los estímulos precedentes y los que siguen a la conducta, y la relación entre variables y consecuencias; equivale al diagnóstico en otros modelos de intervención. *Por ejemplo, es el caso del niño que muestra conductas de enfado cuando sus padres van al colegio a recogerle, con su hermano pequeño en el coche de bebé, da patadas en la pared y finge no verle. una HF podría ser que «… el niño necesita llamar la atención de sus padres, el nacimiento del hermano pequeño le ha hecho sentirse desplazado (celos)».*

2.4.2. Fase de intervención

La fase de intervención se inicia con la formulación de la Hipótesis de intervención (HI), que está basada en la Hipótesis funcional (HF). Continúa la elaboración del programa que incluye la formulación de objetivos generales y específicos, la selección de técnicas, de reforzadores, recursos, situaciones y condiciones, para seguir con la aplicación del programa; se prosigue con la evaluación continua de la intervención y se finaliza con el desvanecimiento progresivo del programa.

Tabla 5.4
Fases del proceso de intervención

Pasos	Tareas
1. Formulación de la hipótesis de intervención	■ Redactar la hipótesis de intervención. «Si se aplican (técnicas de intervención) … se conseguirán (objetivos del programa de intervención)»
2. Elaboración del programa de intervención	■ Formular objetivos y criterios intermedios de logro. ■ Analizar tareas. ■ Seleccionar técnicas, reforzadores y recursos. ■ Decidir situaciones y condiciones: dónde, cuándo y quién se responsabilizará de la aplicación y seguimiento del programa.
3. Aplicación del programa	■ Desarrollar actividades y aplicar técnicas y recursos. ■ Observar y registrar resultados. ■ Comparar resultados con la línea base. ■ Revisar todos los pasos del proceso. ■ Reorganizar el programa si fuera pertinente.

Pasos	Tareas
4. Evaluación continua de la intervención	■ Observar y registrar resultados. ■ Comparar resultados con la línea base. ■ Revisar todos los pasos del proceso. ■ Reorganizar el programa si fuera pertinente.
5. Desvanecimiento del programa	■ Retirar progresivamente reforzadores y recursos. ■ Sustituir reforzadores externos por otros naturales, por el autorrefuerzo y el autocontrol.

Fuente: García Mediavilla, L. y Martínez González, M. de C. (2003). Adaptado de Cidad (2001).

La Hipótesis de intervención (HI) se formula a partir de los contenidos de la hipótesis funcional. Consiste en hacer predicciones sobre la probabilidad y dirección del cambio en la conducta, si se modifican las variables que afectan al problema o la relación que se da entre dichas variables. Se formula en modo condicional: «*Si... aplicamos, hacemos, trabajamos … (técnicas, estrategias) ... entonces conseguiremos, lograremos (objetivos)*»

Por ejemplo, en el caso de un niño que molesta a sus compañeros de clase rompiendo el material, gritando, no respetando el turno de palabra, se podría formular una hipótesis de intervención en estos términos: «*si la profesora y sus compañeros dejan de prestarle atención cuando rompe el material, grita o no respeta el turno de palabra, y se refuerzan las conductas adecuadas (agradeciéndole, reconociendo el cambio, valorando el esfuerzo) como: cuando cuida el material, no grita y respeta el turno de palabra, las conductas anteriores desaparecerán; es decir, cuidará el material, dejará de gritar y respetará el turno de palabra*».

En la primera parte del enunciado de la HI: «*Si... aplicamos, hacemos ...*» se incluyen las técnicas o estrategias para modificar la conducta; en la segunda: entonces (conseguiremos, lograremos.) los objetivos o conductas finales que se quieren alcanzar.

En este apartado, es importante destacar la diferencia existente entre una Hipótesis de intervención y una frase meramente condicional, por ejemplo, «*si su conducta mejora…*», «*si los padres se dan cuenta, si no le permiten, si la profesora les hace ver…*», estos planteamientos son únicamente la expresión de deseos con respecto al cambio de la conducta, pero no constituyen una HI, la HI, dentro de la resolución de un caso determinado, constituye una herramienta de actuación educativa organizada, que tiene el objetivo de facilitar y llevar a cabo la toma de decisiones con respecto a las formas y medios más adecuados y eficaces de intervención.

Elaboración del programa de intervención

La elaboración del programa de intervención implica formular objetivos finales e intermedios, analizar las tareas y actividades previstas para el desarrollo del progra-

ma, seleccionar las técnicas, los reforzadores, los recursos, decidir las situaciones de intervención (dónde se llevará a cabo la intervención, cuándo: horarios, número de sesiones, quién o quiénes se responsabilizarán de la aplicación del programa. Por otra parte, la metodología de intervención y de modificación de conducta requiere que:

- Los objetivos, desde la perspectiva formal se formulan siempre en infinitivo, y en cuanto al contenido de estos, deben ser concretos, observables y cuantificables; por ejemplo, recoger los juguetes, cerrar las puertas sin hacer ruido, no pegar, apagar las luces al salir de habitaciones, etc.
- La selección del tipo de reforzadores que se utilizará, deberá hacerse a partir de la observación que se haya hecho sobre cuáles de ellos resultan más sensibles, en función de la persona, o grupo sobre los que se vaya a intervenir, teniendo en cuenta sus edades, momento evolutivo en el que se encuentran, las características de personalidad, gustos e intereses, entre otros.
- La selección de las técnicas se hará en función de cómo se haya formulado la hipótesis de intervención, las características de la conducta-problema y de la persona o grupo (las mismas variables ya mencionadas), el objetivo final que se quiere alcanzar con la aplicación del programa, las condiciones del entorno y del resto de variables que puedan facilitar o dificultar la intervención.

En el paso aplicación del programa se lleva a la práctica todo lo programado en la fase de elaboración. Se inicia siempre partiendo de la línea base; cuando la conducta es compleja se comienza por los «segmentos de conducta» más problemáticos. Es muy importante observar los efectos de las técnicas para determinar cuáles son las más eficaces, y modificar, cambiar o eliminar cuando dichos efectos lo aconsejen.

Con la evaluación continua de la intervención se pretende verificar en qué medida se están consiguiendo los objetivos intermedios. En función de los resultados, se toman decisiones respecto de la conveniencia o no de la reorganización del programa; en caso afirmativo, se debe revisar cada una de las fases e introducir las modificaciones pertinentes después de haber analizado las posibles causas: formulación imprecisa, defectuosa o errónea de la HF y de la HI, objetivos intermedios imprecisos, selección de técnicas inadecuadas, lugar y tiempo de aplicación inadecuados o imprecisos, efectos negativos secundarios, defectos introducidos por el aplicador, etc.

Cuando los objetivos se han alcanzado, según lo previsto en la elaboración del programa, se procede al desvanecimiento de este; es recomendable hacerlo de forma progresiva y sustituyendo los reforzadores artificiales por los naturales, los extrínsecos por los intrínsecos; finalmente se da por finalizada la aplicación del programa.

2.4.3. Fase de seguimiento

La fase de seguimiento tiene como finalidad verificar si las conductas modificadas se mantienen en el tiempo y se generalizan a situaciones distintas de aquellas en las

que se produjo el aprendizaje; se lleva a cabo en tres pasos sucesivos: 1) programación del seguimiento, 2) mantenimiento y generalización del cambio, 3) evaluación del seguimiento; en la tabla 5.5 se enumeran dichos pasos y las tareas propias de cada uno.

Tabla 5.5
Fase de Seguimiento: pasos y tareas

Pasos	Pases
Programación del seguimiento	■ Delimitación del tiempo y número de sondeos.
Mantenimiento y generalización del cambio	■ Selección de técnicas y recursos para la generalización del cambio.
Evaluación del seguimiento	■ Observación y registro del cambio. ■ Comparación del nivel de conducta actual con la alcanzada al final de la intervención.

Fuente: García Mediavilla, L. y Martínez González, M. de C. (2003). Adaptado de Cidad (2001).

En la programación del seguimiento se describe cómo se realizará este y durante cuánto tiempo. Para optimizar los resultados de este paso, hay que tener en cuenta los resultados obtenidos tras la aplicación del programa, las dificultades o limitaciones que se hayan identificado tanto en el desarrollo como en la generalización de las conductas a contextos diversos, y la mayor o menor utilidad de alguna de las técnicas aplicadas.

En el paso mantenimiento y generalización del cambio se busca asegurar que los objetivos alcanzados se mantengan en el tiempo y se generalicen a otras situaciones y a contextos diferentes, se trata de:

- Conseguir que la persona compruebe que las conductas desarrolladas y/o modificadas son de utilidad en su vida escolar, familiar o social, por ejemplo, aprender a leer y a escribir, ser capaz de identificar y reconocer sus emociones, controlar los impulsos y sentimientos, saludar, dar las gracias, etc.
- Aplicar reforzadores de forma aleatoria e intermitente. Se ha constatado que las conductas se generalizan y mantienen durante más tiempo cuando la persona no puede anticipar cuándo y cómo se va a ser recompensado.
- Transferir las consecuencias derivadas de la aplicación del programa a otros contextos y situaciones diferentes. Si un comportamiento es molesto, por ejemplo gritar, y se ha extinguido con actuaciones (refuerzos, reconocimientos) que los padres dispensan cuando el niño no grita, se mantendrá durante más tiempo si en el colegio se llevan a cabo las mismas actuaciones o similares.
- Modificar los precedentes de la conducta y las consecuencias de la misma; por ejemplo, la profesora que quiere que sus alumnos dejen sus cosas recogidas al

finalizar la clase, conseguirá mejores resultados, si en vez de advertir antes de comenzar la clase y castigar cuando no respetan la norma, no se dice nada antes de empezar la clase, y se alaba cuando se hayan recogido las cosas.

- Modificar el tipo y número de reforzadores; cambiar los materiales por los sociales suele dar buenos resultados cuando la conducta modificada se consolida.
- Entrenar en autorrefuerzo. Esta estrategia se ha mostrado muy eficaz en casi todos los casos y para todo tipo de conductas; los resultados son mejores con adolescentes y niños mayores, ya que se convierten en protagonistas de su propio cambio.

2.5. Técnicas de intervención

El modelo conductual-cognitivo utiliza como instrumentos de intervención las técnicas procedentes de diversas corrientes psicológicas, si bien las específicas son las denominadas *cognitivas, metacognitivas y conductuales*; la descripción de todas ellas se hace en el capítulo 6.

3. MODELO SISTÉMICO O ECOLÓGICO-CONTEXTUAL

Al abordar la intervención con familias desde el modelo sistémico, hay que citar, aunque sea brevemente al Grupo de Palo Alto, al que se debe la aplicación de los conceptos sistémicos a la comprensión de las familias y sus dinámicas de comunicación e interacción en los diversos contextos.

La adopción del modelo sistémico o ecológico-contextual como marco teórico y metodológico para el trabajo con familias en los primeros niveles educativos constituye una forma de análisis e intervención de tipo molar, que va más allá de la persona y de las relaciones diádicas, para centrarse en las relaciones interpersonales que se producen en el marco de la actividad humana. Se ha desarrollado ampliamente, tanto en la práctica clínica como en la acción educativa y en la investigación. Con respecto a la intervención educativa en la que se centra este manual, los ámbitos de interés principal serían:

- Prevención e intervención sobre problemas que puedan afectar a las familias en contextos de riesgo.
- Evaluación de experiencias de acercamiento entre los sistemas familiar, escolar y comunitario: cambio de actitudes y construcción de hábitos.
- Tratamiento sistémico en problemas de comunicación e interrelación entre familias y escuela.

Propieades sistémicas de la familia

La revisión que llevan a cabo Feixas y Viaplana, Muñoz, Compañ y Montesano del Campo, (2012), sobre las aportaciones de representantes clave de este enfoque como Waztlawick et al., 1967; Feixas y Viaplana y Villegas (2000), analiza las implicaciones que tienen las propiedades sistémicas de las familias, y enumeran estas propiedades adaptando el planteamiento de Sánchez García (1988) como se indica a continuación:

- L*a familia como sistema abierto*
  - La familia como conjunto de individuos dinámicamente estructurados. Este conjunto genera normas de funcionamiento, en parte independiente de las que rigen el comportamiento individual.
- *Totalidad*
  - El cambio en un miembro incide en los demás, sus acciones (y significados) están interconectadas mediante pautas de interacción.
  - Las pautas de funcionamiento del sistema familiar son más que la suma de sus miembros
- *Límites*
  - El sistema integra varios subsistemas, y entre estos existen límites con una permeabilidad variable, y se distingue entre difusos, claros y rígidos.
- *Jerarquía*
  - La familia se estructura de manera jerárquica a partir de diversas formas de organización.
- *Retroalimentación*
  - La conducta de cada miembro influye en la de los demás mediante feedback positivo (favorecedor) o negativo (corrector).
- *Equifinalidad*
  - Se puede llegar a una misma pauta de interacción a partir de orígenes diversos.
- *Tendencia a estados constantes*
  - La aparición de redundancias comunicacionales, con el tiempo da lugar a reglas interaccionales que pueden llegar a convertirse en parámetros del sistema.
  - En cada interacción disminuye el número de variedades comunicacionales posibles (proceso estocástico).
  - Los mecanismos que preservan el mantenimiento de las reglas interaccionales se consideran homeostáticos (función de mantener un determinado equilibrio).

Muchas intervenciones de orientación familiar se han basado en la Teoría General de Sistemas, por ejemplo, la prevención de problemas, la identificación, evaluación e intervención con grupos familiares en situación de riesgo, etc. De igual forma y con frecuencia, los programas de habilidades sociales, relaciones interpersonales y de comunicación también se han diseñado en el marco de esta teoría. Las funciones del profesional de la orientación como agente de cambio social o de mediación entre los individuos, los sistemas y los subsistemas tienen mucho que ver con los supuestos de la Teoría General de Sistemas. Este modelo se desarrolla en profundidad en el capítulo 1, por lo que se remite al lector a este para ampliar contenido sobre el mismo.

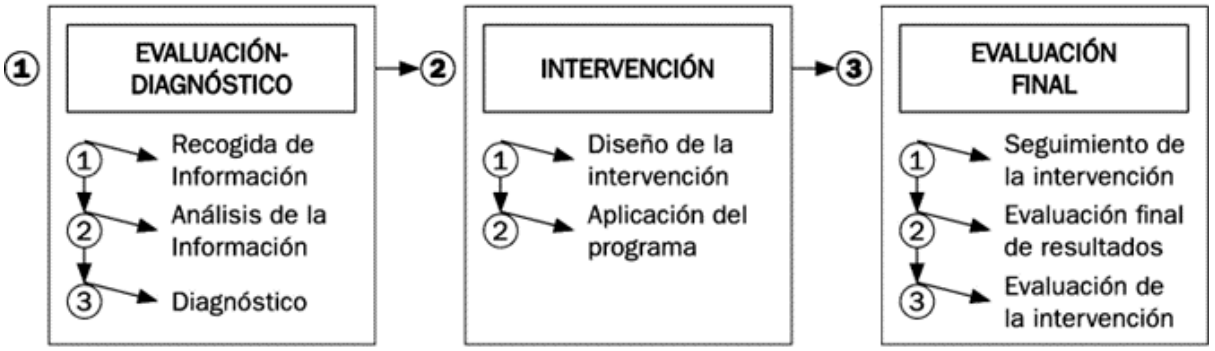
3.1. El proceso de intervención en el modelo sistémico

El proceso de intervención según el modelo sistémico se caracteriza por dos aspectos distintivos que lo diferencian de otras formas de intervenir: ser *abierto* o *flexible* e *integrador*. Abierto significa que, tanto en la fase de diagnóstico como en el diseño del plan de intervención, no sigue un esquema rígido, sino que se acomoda a las características del problema, a las necesidades de la persona o personas destinatarias, y a las posibilidades y formación de los orientadores familiares y demás agentes que se responsabilizan de tareas específicas en este ámbito. Hay que tener en cuenta que, desde un enfoque sistémico, los elementos a tener en cuenta se incrementan, y este aspecto determina que, según el caso de que se trate habrá que adaptar su estructura.

El carácter integrador viene dado por la diversidad de marcos teóricos en los que se basa y porque asume un enfoque ecléctico a la hora de seleccionar estrategias, técnicas o recursos de diferentes escuelas y modelos, por ejemplo, en una intervención desde este enfoque sistémico, también se recurre a elementos (técnicas, estrategias del modelo cognitivo, el conductual o el psicométrico)

No obstante, la aplicación del modelo sistémico, como enfoque de intervención y de forma similar al proceso de intervención cognitivo conductual, sigue tres momentos sucesivos e interdependientes: 1) evaluación-diagnóstico, 2) intervención, 3) evaluación final. En el contexto de este manual, la intervención con familias con hijos e hijas de los niveles educativos de infantil y primaria, el proceso se inicia cuando algún miembro del grupo familiar, del entorno próximo o de instituciones que involucradas en temas familiares solicita asesoramiento sobre una situación específica que afecta al grupo familiar.

Figura 5.1
Proceso de intervención en el modelo sistémico



Fuente: García Mediavilla, L. y Martínez González, M. de C. (2003).

3.1.1. Primera fase: evaluación-diagnóstico

Tal y como se muestra en la figura 5.1, esta fase consta de tres momentos sucesivos e interdependientes:

- ***Paso 1. Recogida de la información***

Este paso es previo a cualquier tipo de análisis y toma de decisiones en un plan de intervención; consiste en recabar toda la información pertinente del caso, para una evaluación completa y rigurosa, integrando la identificación de las personas implicadas en el caso, el motivo de la consulta; cualquier dato relativo a los contextos en los que interactúan los miembros de la familia, su propio entorno, el escolar y el social; el tipo de relaciones que se establecen entre y dentro de estos sistemas. Este conjunto de datos puede clasificarse de acuerdo a diferentes criterios; y en intervenciones de carácter socioeducativo suele seguirse la siguiente secuencia:

a) Datos de identificación

En este primer apartado se recogen los datos de identificación del grupo familiar (datos demográficos), de la persona o personas designadas por la familia como generadora/s del problema; datos del entorno social próximo, así como los datos relativos al centro educativo y las causas que motivan la petición de consulta. Estos datos se registran en protocolos elaborados al efecto.

b) Información del contexto

En este apartado se recogen datos del presente y del pasado del sujeto con relación a los entornos en los que ha vivido y vive. En los casos de orientación familiar son imprescindibles los relativos a la familia en su entorno comunitario, el historial escolar y los datos de carácter evolutivo y médico.

En lo que se refiere a la familia los datos que es preciso recoger serían: tipo de familia, número de hijas e hijos, lugar que ocupa u ocupan las personas

analizadas, nivel económico, contexto cultural de la familia; las relaciones interpersonales, afectivas, organizativas, de colaboración y de comunicación que se establecen entre y dentro de los distintos subsistemas familiares, el tipo de actuaciones que lleva a cabo la familia en la educación de sus hijas e hijos, situaciones especiales, tanto fortalezas como riesgos, por ejemplo, entre los riesgos: trabajo y economía deficitarios, enfermedades, pérdida de seres queridos, divorcio, separación, malos tratos; entre las fortalezas, vínculos afectivos fuertes, apoyo de redes familiares y sociales, disposición colaborativa en el proyecto educativo de los hijos e hijas, etc. En definitiva, ha de recogerse cualquier dato que pueda tener alguna relación o influencia con la o las posibles causas del problema que ha motivado la solicitud de ayuda.

En cuanto a la historia escolar se debe incluir la cadena académica de éxitos y de fracasos, el número de centros educativos a los que se ha asistido la persona o personas que son objeto de la evaluación, así como la existencia de dificultades especiales, tanto de desarrollo como situacionales, si hay historia de absentismo y las razones del mismo, resultados de informes psicopedagógicos, opinión del profesorado que haya estado implicado en el caso, hábitos de estudio, si han existido programas de intervención previos, etc.

En el marco de la historia escolar, y especialmente en los niveles educativos de infantil y primaria, interesan especialmente los datos de carácter evolutivo y médico, entre otros, los relativos al embarazo, parto, alimentación, desarrollo motor, desarrollo del lenguaje oral y escrito, funcionamiento visual y auditivo, enuresis, encopresis, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, problemas sensoriales o físicos, dificultades en la atención, alteraciones psíquicas, enfermedades y trastornos en general, dificultades para calzarse y vestirse, preferencia manual, hospitalizaciones, desarrollo afectivo y emocional. En cada caso concreto interesan los momentos representativos por lo que puedan aportar sobre posibles causas del problema.

En cuanto a los datos referidos al contexto existen diversos procedimientos que se podrán seleccionar o combinar en función del caso concreto de que se trate, por ejemplo, la entrevista, el análisis de documentos (expediente escolar, historial de salud, informes médicos, estudios psicopedagógicos), cuestionarios, registros de conducta, observación en sesiones individuales o grupales, aplicación de pruebas específicas de evaluación y diagnóstico.

c) Información específica sobre el motivo de la petición de ayuda

La información recogida sobre el contexto unida a las causas que motivaron la petición de ayuda permiten una aproximación al problema y delimitar el campo de análisis; para completarlo se pueden aplicar pruebas específicas: cualitativas y cuantitativas, como cuestionarios, escalas de valoración, listas de control, anecdotarios de aula, etc.

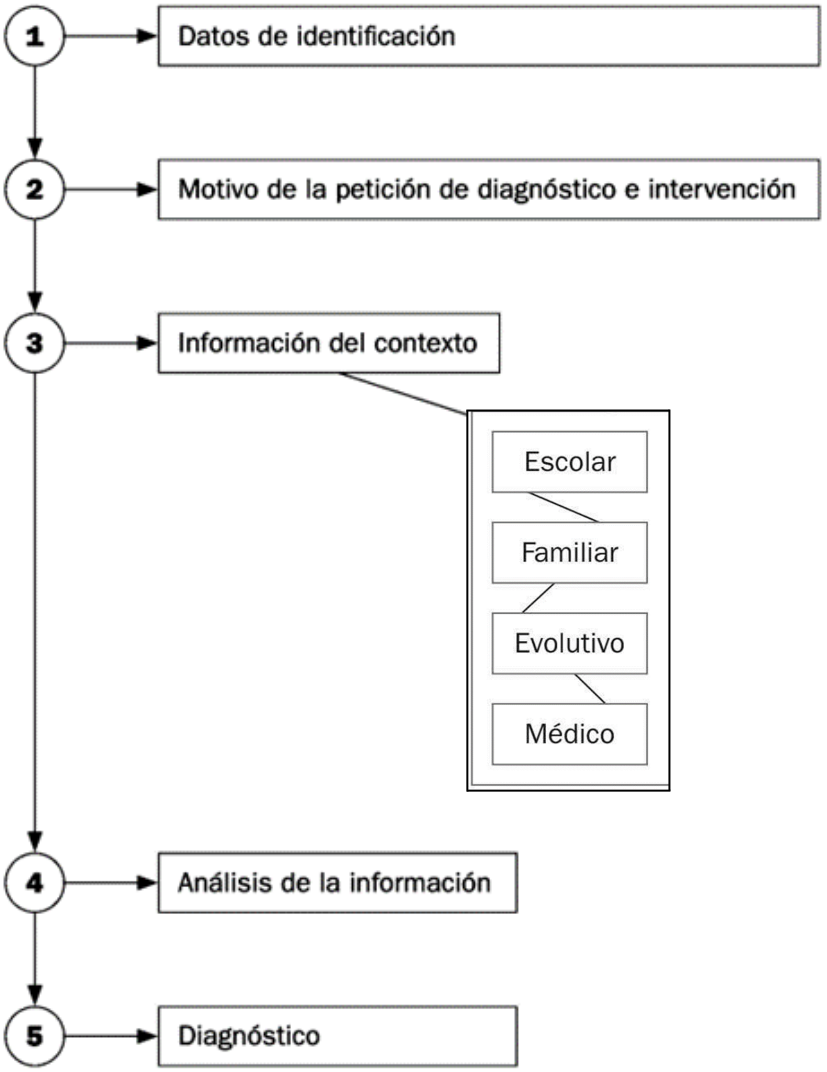
- ***Paso 2. Análisis de la información***

Las tareas específicas del paso 2 son: seleccionar la información distinguiendo los datos relevantes de los anecdóticos, se analizarán los datos relevantes, interpretándolos y elaborando la valoración funcional de los datos obtenidos.

- ***Paso 3. Elaboración del diagnóstico y toma de decisiones***

Esta fase de valoración finaliza con la elaboración del diagnóstico, la redacción del informe en el que se suele incluir la modalidad de intervención psicopedagógica o socioeducativa recomendada.

Figura 5.2
Fase de valoración-diagnóstico



Fuente: García Mediavilla, L. y Martínez González, M. de C. (2003).

3.1.2. Segunda fase: intervención

La fase de intervención se inicia una vez que se ha realizado el diagnóstico, redactado el informe y tomado decisiones sobre el tipo de intervención socioeducativa más conveniente al caso y al contexto en el que se da el problema.

Como ya hemos indicado en los epígrafes anteriores, el modelo sistémico se caracteriza por ser abierto, flexible, integrador y ecléctico tanto por la fuentes teóricas en las que se fundamenta como en la estructuración de la intervención y en el uso que hace de técnicas y recursos propios de otras tendencias en orientación y terapia familiar; esto hace que haya una gran diversidad metodológica en la forma de concretar la intervención. Nosotros hemos optado por la que proponemos a continuación; nuestra opción está fundamentada en la revisión de numerosos trabajos, en la observación de la práctica profesional de orientadores y terapeutas y en nuestra propia experiencia.

La fase de intervención se lleva a cabo en pasos sucesivos e íntimamente interrelacionados: 1) diseño o elaboración de la intervención, 2) aplicación del tipo de intervención diseñada para el caso

- ***Paso 1. Diseño o elaboración de la intervención***

En este paso se llevan a cabo las siguientes actividades: formulación clara y precisa de los objetivos finales, relación de las actuaciones generales y actividades concretas destinadas a la consecución de los objetivos, selección de técnicas y estrategias que se van a aplicar, concreción de otros medios materiales que se consideren necesarios o posibles, relación de profesionales con responsabilidades concretas en algún momento de la intervención, identificación de los destinatarios (personas individualmente consideradas, grupo y/o subgrupo familiar), previsión del tiempo total que puede durar la aplicación del programa o terapia y distribución del número de sesiones previstas, determinación del número de sesiones previstas, diseño del plan y del tipo de seguimiento que se quiere llevar a cabo durante el tiempo que dure el proceso de ayuda a la familia o la terapia.

- ***Paso 2. Aplicación del tipo de intervención diseñada para el caso concreto***

La aplicación de la intervención ha de hacerse, en principio, según el diseño elaborado para el caso. Generalmente es el orientador o el terapeuta el que asume la responsabilidad de que se ejecute adecuadamente, siguiendo el proceso e introduciendo cuantas modificaciones sean pertinentes; el resto de los trabajadores y personas intervinientes llevan a cabo tareas de apoyo. Lo más frecuente es que el trabajo de unos y de otros se ajuste a protocolos específicos diseñados para el caso. En orientación y terapia familiar, Ríos (2001) estructura lo que él denomina proceso terapéutico en torno a diez puntos; de esta forma pretende que la familia sea vista como una unidad de tratamiento en la que se consiga la solución de las dificultades de un miembro de cara a su maduración.

1. Modificar el sistema de relaciones interpersonales; las técnicas más adecuadas son la estimulación verbal, directa y sin códigos, no importa, en este momento del proceso, que aparezcan crisis momentáneas.
2. Estimular la utilización de interacciones positivas mediante el descubrimiento de cualidades en cualquiera de las personas que participan en la terapia.
3. Enriquecer la red de interacciones familiares creando centros de interés en los que participen todos.
4. Delimitar los subsistemas (adultos, niños, hijos-niños, hijos-adolescentes, etc.) para que cada cual tenga definida su identidad y lugar en el contexto familiar.
5. Flexibilizar las actitudes educativas y las formas de trabajar; con ello se consigue eliminar la rigidez que puede llegar a ser patógena o disfuncional en relación a la edad y al grado de autonomía que cada uno necesita.
6. Reestructurar la jerarquía sana y equilibrada dentro del sistema familiar potenciando la autoridad compartida.
7. Fomentar un estilo educativo en el que autoridad y disciplina se ejerzan de forma equilibrada.
8. Ofrecer modelos de disciplina que no destruyan la interacción.
9. Fomentar el desarrollo de valores que faciliten la toma de decisiones de forma autónoma.
10. Poner a cada miembro en el lugar que le corresponde en función de su momento evolutivo y su pertenencia a un subsistema. Con ello se persigue la cohesión interna personal, la estabilidad emocional y el progreso individual dentro del sistema familiar.

El proceso terapéutico de Ríos es generalizable a cualquier subsistema del grupo familiar y a otros sistemas relacionados con la familia, concretamente al sistema escolar; en este sentido, la escuela se entiende como una unidad de tratamiento interviniendo en todo el sistema; las actuaciones concretas se traducen en pautas-guía en la intervención a través de programas o de cualquier otro tipo de recurso.

3.1.3. Tercera fase: seguimiento y evaluación final

La última de las fases se inicia con el seguimiento de la intervención y finaliza con la evaluación del proceso seguido y de los resultados alcanzados.

El seguimiento de la intervención tiene como finalidad asegurarse de que los logros alcanzados con la intervención se mantienen en el tiempo y se generalizan a situaciones distintas de aquellas en las que se dio el aprendizaje. «Es indispensable realizar un seguimiento cercano de variaciones en las condiciones socio-ambientales del sujeto y de la evolución de sus capacidades personales e interrelaciones con el medio, con

la finalidad de adecuar, en cada caso, para variar, modificar, la propuesta inicial de trabajo» (Del Campo, 1997, 102). La forma de llevar a cabo el seguimiento difiere mucho de unos casos a otros; la observación del comportamiento de las personas y de los grupos suele ser la forma más utilizada.

Cuando a través de la observación se advierte que los objetivos se han alcanzado, se procede a la evaluación final de todo el proceso y de los resultados. En cada caso se eligen las pruebas más adecuadas; en ocasiones serán necesarias las de carácter psicométrico, las proyectivas o las sociométricas; es competencia del orientación familiar o del terapeuta la aplicación de las mismas y su interpretación.

Como ya hemos indicado repetidamente, la flexibilidad propia del modelo y las características concretas de muchos de los casos que se le presentan al orientador familiar, permite variaciones en el esquema de trabajo; son muchos los orientadores familiares que lo hacen con el siguiente:

Cuadro 5.1
Resumen del proceso de intervención en el modelo Sistémico

1. **Denominación del caso**
2. **Datos de identificación**
3. **Motivos de la intervención**
4. **Recogida de información sobre el contexto:**
   - Información familiar
   - Información escolar
   - Información social
   - Información sobre el proceso evolutivo del sujeto
5. **Diagnóstico:**
   - Áreas exploradas
   - Pruebas aplicadas
   - Resultados de la aplicación de las pruebas
   - Incidencia del problema en otras áreas del comportamiento
   - Valoración global
6. **Intervención:**
   - Diseño de la intervención o del programa
   - Aplicación del programa
7. **Seguimiento y evaluación:**
   - Seguimiento de la intervención
   - Evaluación final del proceso y de los resultados

Fuente: Martínez-González, Álvarez-González y Suárez Fernández, (2009).

Las características más destacadas del modelo sistémico son: el carácter abierto, flexible e integrador, y están presentes en la propia conceptualización de dicho modelo, en el proceso de intervención y mucho más en las técnicas que se utilizan como instrumento de trabajo; en buena parte de la bibliografía dedicada a la terapia y a la

orientación sistémica, se insiste en que el/la orienatador/a, o el terapeuta ha de crear su propio modo de intervenir y seleccionar las técnicas que considere más pertinentes, sin centrarse demasiado en la corriente o escuela de las que provienen; son muy utilizadas las conductuales, cognitivas y metacognitivas; las molares y las multimodales.

3.2. Conclusiones

A partir del análisis de las aportaciones a la orientación familiar de las teorías expuestas, se plantean algunas conclusiones que, pueden responder a nuestra postura con respecto al modelo sistémico o ecológico-contextual.

- La orientación educativa en la familia se fundamenta en el proceso de maduración del ser humano, que se basa en las relaciones que se establecen entre los miembros que forman el grupo familiar, el centro educativo y el contexto comunitario.
- Las conductas de las personas y de los grupos, así como los procesos evolutivos y de maduración no se explican como algo individual y singular, sino como el resultado de «interacciones y circularidades» desarrolladas dentro del sistema familiar.
- La orientación, tanto en la evaluación, como en la intervención y seguimiento, no se centra exclusivamente en el caso problema, sino en el «sistema relacional» del que forma parte la persona o el grupo, y así se atenderá a la interacción entre subsistemas familiares (subsistemas de la pareja, filio-parental, fraternal, familia extensa).
- La orientadora, el orientador, deben ser profesionales expertos a la hora de identificar las estrategias del juego sistémico que, tanto las familias como la escuela ponen en práctica, en actuar sobre dichas estrategias, en modificar las interrelaciones que dificulten el crecimiento personal, así como en la prevención de dificultades y la solución de problemas.
- Cualquier problema debe abordarse desde enfoques en los que los procesos (evaluación, intervención, seguimiento) se lleven a cabo teniendo en cuenta los elementos relacionales que el propio proceso implica.
- El enfoque sistémico se centra en el análisis de los diversos contextos. La persona es un elemento, un eslabón del sistema en el que ha nacido, crece y se desarrolla; el problema es el resultado de un modo de comunicación disfuncional en el interior del sistema.
- No deben considerarse los síntomas como problemas, ni tampoco la configuración ni la estructura familiar (diversidad de tipos de familias) será la responsable de determinados problemas y necesidades educativas de los hijos, sin embargo, sí se puede y debe detectar de qué forma un sistema familiar se relaciona con dichos problemas y necesidades.

- El modelo sistémico facilita la comprensión de situaciones y problemas complejos.
- El enfoque sistémico no culpa, no asigna responsabilidades, lo que facilita el trabajo y mejora la eficacia de las intervenciones.

REFERENCIAS

Bandura, A. (1971) *Social learning theory*. Ed. McCaleb-Seiler.

Bandura, A. (1983). *Principios de modificación de conducta*. Salamanca: Sígueme.

Bertalanffy, L. (1984). *Tendencias en la Teoría General de Sistemas*. Madrid: Alianza Editorial.

Caballo, V.E. (1991). *Manual de técnicas de terapia y modificación de conducta*. Madrid: Siglo XXI.

Cidad Maestro, E. (2001). *Modificación de conducta en el aula e integración escolar*. Madrid: UNED.

Del Campo Adrián, E. y otros (1997). *Casos prácticos de dificultades de aprendizaje y necesidades educativas especiales. Diagnóstico e intervención psicoeduativa*. Madrid: Ramón Areces.

Espe-Sherwindt, M. (2008). Family-centred practice: collaboration, competency and evidence. *Support for learning, 23*(3), 136-143.

Feixas y Viaplana, G., Muñoz Cano, D., Compañ Felipe, V., & Montesano del Campo, A. (2012). *El modelo sistémico en la intervención familiar*. Universidad de Barcelona. http://diposit. ub.edu/dspace/bitstream/2445/31584/1/Modelo_Sistemico_2012_2013r. pdf.

Feixas y Viaplana, G., & Villegas, M. (2000). La epistemología constructivista. G. Feixas y M. Villegas, *Constructivismo y psicoterapia* (3ª ed.) España: Desclée De Brouwer, 29-102.

García-Mediavilla, L. & Martínez-González, M. D. C. (2003).*Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos*. Dykinson.

García Mediavilla, L., y Codés Martínez González, M. D. (2003). El modelo sistémico: fundamentos teóricos y técnicas. En García Mediavilla, L. y Martínez González, M. d. C. *Orientación educativa en la familia y en la escuela: casos resueltos*. Dykinson.

García-Sánchez, F. A., Escorcia, C. T., Sánchez-López, M. C., Orcajada, N., & Hernández-Pérez, E. (2014). Atención temprana centrada en la familia. *Siglo cero, 45*(3), 6-27.

Hervás Aviles, R. M. (2005). *Estilo de enseñanza y aprendizaje en escenarios educativos*. Granada: Grupo editorial universitario.

Ríos González, J.A. y otros (2001). El modelo sistémico en el contexto escolar: ¿Puede ser un método eficaz de prevención. En *Cuadernos de Terapia Familiar, 48* (117-132).

Sánchez García, E. F. (1988). La familia como sistema abierto. *Apuntes de Psicología*, (27), 22-25.